Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition

Vol. 3 (2026)
Chapitre 2

FICHE DE SYNTHÈSE · FACT SHEET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E5



Déterminants de santé, inégalités et mesure de l'état de santé

Determinants of health, social and territorial inequalities, and measuring the health of a population

REVUE BC3 · DIÉTÉTIQUE, NUTRITION & SANTÉ PUBLIQUE

Cahiers de santé publique appliquée à la nutrition · Vol. 3 (2026) · Chapitre 2

Fiche de synthèse · Fact sheet

Fiche de révision et fiches-outils – Chapitre 2

Déterminants de santé, inégalités sociales et territoriales, mesure de l'état de santé d'une population

Determinants of health, social and territorial inequalities, and measuring the health of a population

Dossier pédagogique personnel · BTS Diététique et nutrition, bloc BC3 (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement 2025)

INFORMATIONS

Volume fiche de révision et fiches-outils

Chapitre 2

Version du 25 octobre 2026

Source : cours complet BC3, contrôlé (référentiel 2024, guide 2025)

MOTS-CLÉS / KEYWORDS

Déterminants de santé; Inégalités; Mesure de l'état de santé

RÉSUMÉ STRUCTURÉ

Contexte. Bloc de compétences 3 du BTS Diététique et nutrition (référentiel du 27 novembre 2024, guide d'accompagnement du 29 avril 2025), épreuve E5.

Objectif. définir un déterminant de santé et présenter les principaux modèles (Lalonde 1974, Dahlgren et Whitehead 1991, Commission des déterminants sociaux de la santé de l'OMS 2008) ; identifier les déterminants de l'alimentation d'une population (individuels, socioculturels, économiques, environnementaux, politiques) ; définir les inégalités sociales et territoriales de santé, le gradient social, et expliquer leurs mécanismes ; définir et calculer les principaux indicateurs démographiques (taux de natalité, indicateur conjoncturel de fécondité, espérance de vie, espérance de vie sans incapacité, rapport de dépendance) ; définir et calculer les indicateurs de mortalité (taux brut, spécifique, standardisé, mortalité infantile, prématurée, évitable) et de morbidité (prévalence, incidence, affections de longue durée, recours aux soins) ; lire et interpréter une pyramide des âges.

Contenu. 1. Les définitions à savoir ; 2. Les trois modèles de déterminants ; 3. Les formules ; 4. Chiffres-clés ; 5. Les pièges ; 6. Méthode express : portrait de territoire en 6 étapes ; 7. Auto-test ; 8. Flashcards ; Compléments du chapitre enrichi ; O2.1 – Grille des déterminants de l'alimentation de mon public.

Conclusion. La fiche rassemble l'essentiel du chapitre et ses outils pour réviser vite.

ABSTRACT

Determinants of health, social and territorial inequalities, and measuring the health of a population. This fact sheet belongs to block 3 of the French BTS in dietetics and nutrition (public health interventions, exam E5) and follows the 2024 national curriculum.

POINTS CLÉS

■ définir un déterminant de santé et présenter les principaux modèles (Lalonde 1974, Dahlgren et Whitehead 1991, Commission des déterminants sociaux de la santé de l'OMS 2008) ;

■ identifier les déterminants de l'alimentation d'une population (individuels, socioculturels, économiques, environnementaux, politiques) ;

■ définir les inégalités sociales et territoriales de santé, le gradient social, et expliquer leurs mécanismes ;

■ définir et calculer les principaux indicateurs démographiques (taux de natalité, indicateur conjoncturel de fécondité, espérance de vie, espérance de vie sans incapacité, rapport de dépendance) ;

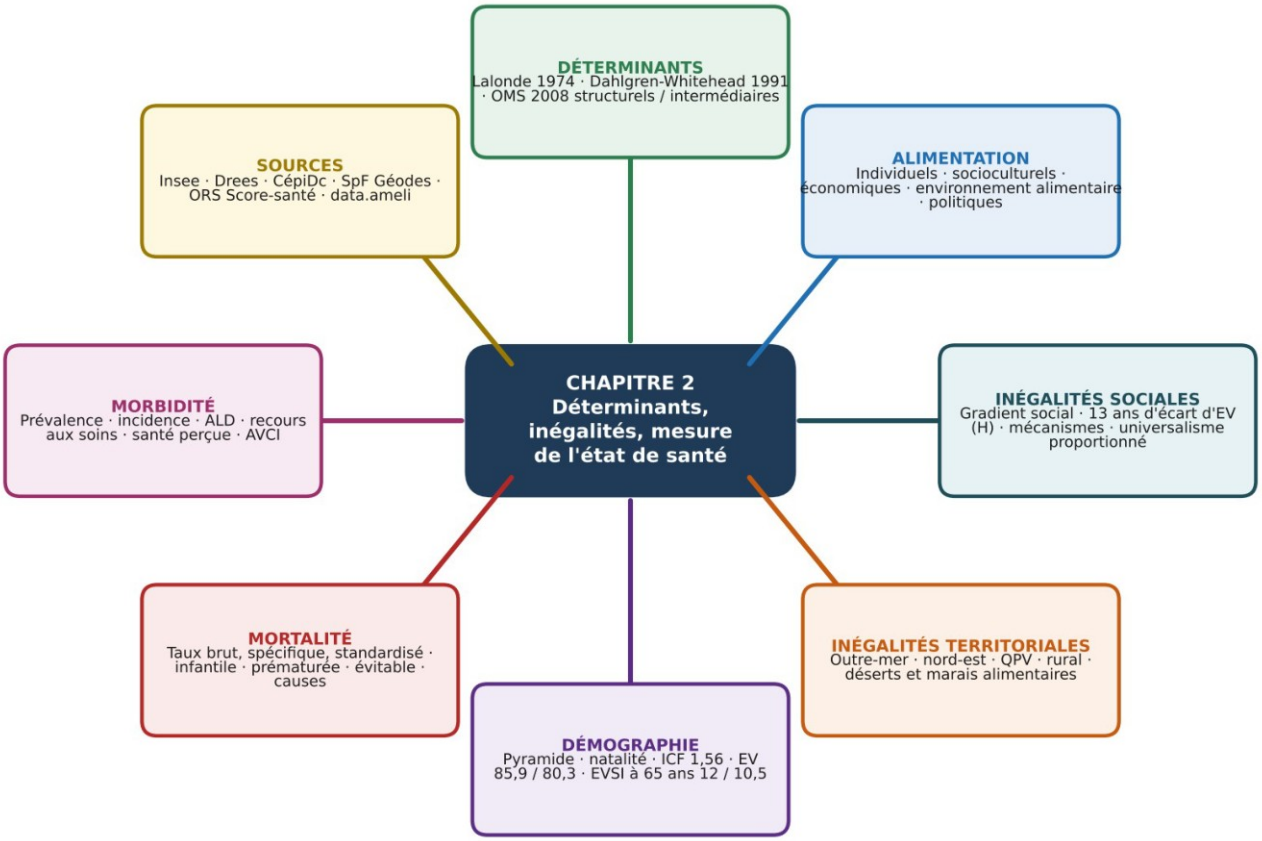
■ définir et calculer les indicateurs de mortalité (taux brut, spécifique, standardisé, mortalité infantile, prématurée, évitable) et de morbidité (prévalence, incidence, affections de longue durée, recours aux soins) ;

Sommaire

Fiche de révision du chapitre 2 4
1. Les définitions à savoir 4
2. Les trois modèles de déterminants 4
3. Les formules 4
4. Chiffres-clés 5
5. Les pièges 5
6. Méthode express : portrait de territoire en 6 étapes 5
7. Auto-test 5
8. Flashcards 5
Compléments du chapitre enrichi 5
Fiches-outils du chapitre 2 5
O2.1 – Grille des déterminants de l'alimentation de mon public 6
O2.2 – Tableau d'indicateurs comparés 6
O2.3 – Calcul d'un taux standardisé (méthode directe) 6
O2.4 – Repérer les inégalités dans mon projet 6
O2.5 – Grille de lecture critique d'un indicateur 6

Fiche de révision du chapitre 2

Déterminants de santé, inégalités sociales et territoriales, mesure de l'état de santé



Carte mentale du chapitre 2

1. Les définitions à savoir

Notion · Définition · Source

Déterminant de santé — *Définition :* Facteur personnel, social, économique, environnemental ou politique qui influence l'état de santé ; *Source :* OMS, 1998

Inégalités sociales de santé — *Définition :* Différences de santé systématiques, socialement produites, évitables et injustes ; *Source :* OMS 2008

Gradient social — *Définition :* La santé s'améliore à chaque échelon de l'échelle sociale ; *Source :* Marmot

Environnement alimentaire — *Définition :* Conditions de disponibilité, accessibilité, attractivité et qualité des aliments ; *Source :* –

Précarité alimentaire — *Définition :* Difficulté d'accès à une alimentation sûre, diversifiée, de qualité et suffisante ; *Source :* Art. L. 266-1 CASF

Espérance de vie — *Définition :* Durée de vie moyenne d'une génération fictive soumise aux taux de mortalité de l'année ; *Source :* Insee

EVSI — *Définition :* Années de vie sans limitation d'activité ; *Source :* Drees

Prévalence / incidence — *Définition :* Cas existants à un instant / nouveaux cas sur une période rapportés à la population à risque ; *Source :* –

2. Les trois modèles de déterminants

Modèle · Contenu

Lalonde (1974) — *Contenu :* Biologie humaine – environnement – habitudes de vie – organisation des soins

Dahlgren et Whitehead (1991) — *Contenu :* 5 couches : individu ; style de vie ; réseaux ; conditions de vie et de travail ; conditions générales

OMS (2008, Solar et Irwin 2010) — *Contenu :* Structurels (contexte, position sociale) → intermédiaires (matériels, psychosociaux, comportements, système de santé) → équité

3. Les formules

Indicateur · Formule

Taux brut de natalité / mortalité — *Formule :* Naissances (ou décès) / population moyenne × 1 000

Taux spécifique — *Formule :* Décès du groupe / population du groupe × 1 000

Taux standardisé direct — *Formule :* (taux spécifique × pop. de référence du groupe) / pop. de référence totale Σ

Mortalité infantile — *Formule :* Décès < 1 an / naissances vivantes × 1 000

Rapport de dépendance — *Formule :* (< 20 ans + ≥ 65 ans) / (20-64 ans) × 100

Indice de vieillissement — *Formule :* ≥ 65 ans / < 20 ans × 100

Prévalence — *Formule :* Cas existants / population

Incidence cumulée — *Formule :* Nouveaux cas / population à risque au début

Écart en points / écart relatif — *Formule :* A − B / (A − B) / B × 100

4. Chiffres-clés

- 69,1 millions d'habitants (1er janvier 2026) ; 22,2 % de 65 ans ou plus ; ICF 1,56 ; solde naturel – 6 000 en 2025 (Insee).
- Espérance de vie 2025 : 85,9 ans (F), 80,3 ans (H) ; EVSI à 65 ans (2024) : 11,8 ans (F), 10,5 ans (H).
- 641 046 décès en 2024 : tumeurs 27,1 %, maladies cardio-neurovasculaires 21,2 %.
- ≈ 13 ans (H) et 8 ans (F) d'écart d'espérance de vie entre les 5 % les plus aisés et les plus modestes (Insee, 2018).
- Obésité 18,1 % ; 24,7 % en cas de difficultés économiques ; 22,4 % en outre-mer (OFÉO, 2024). Précarité alimentaire 16 % (Crédoc, 2022).

5. Les pièges

Attention

- Comparer deux territoires avec des **taux bruts** → utiliser des taux **standardisés**.
- Confondre **effectif**, **proportion** et **taux**.
- Oublier d'exclure les malades du dénominateur de l'**incidence**.
- Confondre écart **en points** et écart **relatif**.
- Croire que les inégalités ne concernent que les plus pauvres (oubli du **gradient**).
- Présenter une donnée sans **année** ni **source**.

6. Méthode express : portrait de territoire en 6 étapes

1. Délimiter le territoire et le public. 2. Démographie (Insee). 3. Situation sociale (Insee, QPV). 4. État de santé (ORS, Géodes, Assurance maladie, santé scolaire). 5. Déterminants et ressources (observation, entretiens). 6. Comparer, dater, sourcer, rédiger 3 à 5 constats.

7. Auto-test

1. Citez les 4 champs de Lalonde. 2. Donnez un déterminant structurel et un intermédiaire. 3. Qu'est-ce que le gradient social ? 4. Écart d'espérance de vie entre hommes aisés et modestes ? 5. Formule du taux de mortalité infantile ? 6. Pourquoi standardiser ? 7. ICF en 2025 ? 8. Première cause de décès ? 9. Une commune : 200 décès, 25 000 habitants : taux brut ? 10. Prévalence 45/320 ? 11. Définition d'un marais alimentaire ? 12. Quelle loi définit la lutte contre la précarité alimentaire ? *Réponses : 1. Biologie, environnement, habitudes de vie, organisation des soins – 2. Revenu / consommation de sodas – 3. Santé meilleure à chaque échelon social – 4. ≈ 13 ans – 5. Décès < 1 an / naissances vivantes × 1 000 – 6. Pour éliminer l'effet de la structure par âge – 7. 1,56 – 8. Tumeurs (27 %) – 9. 200 / 25 000 × 1 000 = 8,0 ‰ – 10. 14,1 % – 11. Zone saturée d'offre peu favorable (restauration rapide) – 12. Loi EGalim (art. L. 266-1 CASF).*

8. Flashcards

Recto : Déterminants structurels selon l'OMS ? · Verso : Contexte socio-économique et politique + position sociale (éducation, profession, revenu, genre, origine)

Recto : Taux standardisé direct : principe ? — *Verso : Contexte socio-économique et politique + position sociale (éducation, profession, revenu, genre, origine) :* Verso : Appliquer les taux par âge de chaque population à une même population de référence

Recto : EVSI à 65 ans (2024) ? — *Verso : Contexte socio-économique et politique + position sociale (éducation, profession, revenu, genre, origine) :* Verso : 11,8 ans (femmes) ; 10,5 ans (hommes)

Recto : Prévalence = ? — *Verso : Contexte socio-économique et politique + position sociale (éducation, profession, revenu, genre, origine) :* Verso : ≈ incidence × durée (situation stable)

Recto : Désert vs marais alimentaire ? — *Verso : Contexte socio-économique et politique + position sociale (éducation, profession, revenu, genre, origine) :* Verso : Manque d'accès aux aliments frais / excès d'offre peu favorable

Recto : Causes de décès 2024 ? — *Verso : Contexte socio-économique et politique + position sociale (éducation, profession, revenu, genre, origine) :* Verso : Tumeurs 27,1 % ; cardio-neurovasculaires 21,2 %

Compléments du chapitre enrichi

Notion · À retenir

Transitions — *À retenir :* Démographique (4 phases) ; épidémiologique (Omran, 1971) ; nutritionnelle (Popkin) ; double fardeau

Vieillissement — *À retenir :* Indice = 65+ / moins de 20 ans × 100 ; dépendance = (moins de 20 + 65+) / 20-64 × 100

Fardeau — *À retenir :* Adultes : 49 % surpoids dont 17 % obésité (Esteban 2015) ; 41 % des cancers liés à des facteurs modifiables (CIRC 2018) ; AVCI = AVP + AVI

Association — *À retenir :* RR = R1/R0 ; DR = R1 − R0 ; OR = ad/bc ; FA = (RR − 1)/RR ; association ≠ causalité ; confusion

Inégalités — *À retenir :* Obésité GS : 5,8 % (ouvriers) / 1,3 % (cadres) ; insécurité alimentaire 11 % (INCA 3) ; 16 % (Crédoc 2022) ; écart absolu et relatif

Enquêtes — *À retenir :* INCA 3, Esteban, Albane, Elfe, NutriNet-Santé, Constances, SNDS ; transversale / cohorte / essai

Coût — *À retenir :* Journée conforme aux repères ≈ 3,5 € (exemple) ; comparer par portion ; lentilles 0,16 € la portion

Périnatalité — *À retenir :* Mortalité infantile ≈ 4 ‰ ; prématurité, petits poids, allaitement, certificats du 8e jour, 9e et 24e mois

Fiches-outils du chapitre 2

Outil · Intitulé · Utilité

O2.1 — *Intitulé :* Grille des déterminants de l'alimentation de mon public ; *Utilité :* Analyser les causes d'un problème (F1, F2)

O2.2 — *Intitulé :* Tableau d'indicateurs comparés territoire / référence ; *Utilité :* Construire le portrait chiffré

O2.3 — *Intitulé :* Calcul d'un taux standardisé (méthode directe) ; *Utilité :* Comparer deux territoires

O2.4 — *Intitulé :* Repérer les inégalités sociales et territoriales dans mon projet ; *Utilité :* Appliquer l'universalisme proportionné

O2.5 — *Intitulé :* Grille de lecture critique d'un indicateur ; *Utilité :* Vérifier un chiffre avant de le citer

O2.1 – Grille des déterminants de l'alimentation de mon public

Catégorie	Déterminants observés (avec source)	Levier possible
Individuels (âge, santé, goûts, compétences, temps)		
Sociaux et culturels (famille, normes, religion, culture)		
Économiques (revenus, prix, aides)		
Environnement alimentaire (commerces, restauration, marketing)		
Environnement physique (logement, équipement, transports)		
Politiques et systèmes (cantine, aide alimentaire, programmes)		

O2.2 – Tableau d'indicateurs comparés

Indicateur	Mon territoire	Département	Région / France	Écart (points ou rapport)	Source et année
Population					
Moins de 20 ans (%)					
65 ans ou plus (%)					
Taux de pauvreté (%)					
Familles monoparentales (%)					
Sans diplôme (%)					
Espérance de vie / ICM					
Mortalité prématurée (taux standardisé)					
ALD diabète (taux standardisé)					
Surpoids des enfants					

O2.3 – Calcul d'un taux standardisé (méthode directe)

Âge	Pop. A	Décès A	Taux A (‰)	Pop. B	Décès B	Taux B (‰)	Pop. de référence
Total							

Calcul	Territoire A	Territoire B
Taux brut = décès / population × 1 000		
Décès attendus = (taux spécifique × pop. de référence / 1 Σ 000)		
Taux standardisé = décès attendus / pop. de référence × 1 000		
Conclusion		

O2.4 – Repérer les inégalités dans mon projet

Question	Réponse
Quels groupes de mon public sont les plus défavorisés	
(revenu, quartier, langue, handicap, isolement) ?	
Quelles barrières risquent de les empêcher de participer	
(horaires, coût, transport, lecture, numérique) ?	
Quelle partie de l'action est universelle (pour tous) ?	
Quel renforcement pour les plus défavorisés	
(universalisme proportionné) ?	
Quel indicateur me permettra de vérifier que l'action	
profite aussi aux plus défavorisés ?	
Quelles précautions pour ne pas stigmatiser ?	

O2.5 – Grille de lecture critique d'un indicateur

Question	Réponse	OK ?
Quel est l'indicateur exact (numérateur, dénominateur, unité) ?		☐
Quelle population (âge, sexe, territoire) ?		☐
Quelle année de recueil ?		☐
Mesuré ou déclaré ? Quel échantillon ?		☐
Taux brut ou standardisé ?		☐
Quelle valeur de référence pour comparer ?		☐
Quelle source (organisme, document, lien) ?		☐